

TEMA 5.10 • HEMATOLOGÍA

Anemia en Niños

PERFIL EUNACOM 1.07.1.010

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Anemia en Niños

Diagnóstico: Puntos de corte por edad

No hay un valor fijo: se diagnostica **Anemia: Generalidades**anemia cuando Hb < **percentil 3** para la edad (equivale a -2 DE).

TABLA 5.10.1: EDAD VS HB "NORMAL" APROXIMADA	
EDAD	HB "NORMAL" APROXIMADA
Recién nacido	~15 g/dL (< 15 = anemia)
2–6 meses	Zona de anemia fisiológica (ver abajo)
> 6 meses	~11 g/dL (< 11 = anemia)

Anemia Fisiológica del Lactante

- **Rango de edad:** 2–6 meses
- Mecanismo: intercambio de Hb fetal → Hb adulta + eritropoyesis aún insuficiente
- **Punto de corte:** Hb ≥ 9 → anemia fisiológica normal (solo observar)
- **Si Hb < 9 en 2–6 meses → anemia no fisiológica → buscar causa**

EUNACOM CRITERIOS
Anemia fisiológica = normal y esperada. NO requiere tratamiento. El error es tratarla innecesariamente.

Causas según edad

TABLA 5.10.2: EDAD VS CAUSA MÁS FRECUENTE	
EDAD	CAUSA MÁS FRECUENTE
Recién nacido	Hemólisis por anticuerpos maternos (Rh, ABO) o alfa-talasemia
2–6 meses	Anemia fisiológica; también talasemia beta si ya inicia
> 6 meses	Anemia ferropénica (la más frecuente por lejos)

Caso especial: Déficit de B12 en lactante

- Madre vegana + **lactancia materna** exclusiva sin suplemento → posible déficit de B12 → anemia macrocítica + compromiso neurológico

Casos clínicos tipo

TABLA 5.10.3: CASO VS HB		
CASO	HB	DIAGNÓSTICO
RN, Hb 13	< 15	Anemia del RN
Lactante 3 meses, Hb 10	≥ 9	Anemia fisiológica → solo observar
Lactante 4 meses, Hb 8,5	< 9	Buscar causa (no es fisiológica)

| Lactante 12 meses, Hb 10, VCM 70 | < 11 | Anemia ferropénica → suplementar hierro |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM
ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO: "Lactante de 4 meses con hemoglobina de 8 g/dL. ¿Cuál es la conducta más apropiada?"
EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA: Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Anemia en Niños. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS
• El diagnóstico de anemia en niños se hace cuando la hemoglobina está bajo el percentil 3 para la edad • Al nacer el punto de corte es ~15 g/dL; desde los 6 meses se estabiliza en ~11 g/dL • La anemia fisiológica del lactante ocurre entre 2-6 meses; punto de corte: 9 g/dL • Bajo hemoglobina de 9 en un lactante de 2-6 meses hay que buscar causa secundaria • En el recién nacido: hemólisis por incompatibilidad de grupo/Rh y anemias genéticas • Después de los 6 meses: la ferropénica es la causa más frecuente por lejos • Déficit de B12 en niños: madre vegana con lactancia materna exclusiva sin suplementos

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ANEMIA EN NIÑOS)

PREGUNTA 1

Lactante de 4 meses con hemoglobina de 8 g/dL. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- ☐ A) Diagnosticar anemia fisiológica del lactante y observar
- ☐ B) Buscar causa secundaria de anemia
- ☐ C) Suplementar hierro de inmediato
- ☐ D) Transfundir concentrado de glóbulos rojos
- ☐ E) Solicitar electroforesis de hemoglobina

PREGUNTA 2

Recién nacido con hemoglobina de 13 g/dL. ¿Cuál es la interpretación correcta?

- ☐ A) Hemoglobina normal para un recién nacido
- ☐ B) Anemia, ya que el punto de corte neonatal es ~15 g/dL
- ☐ C) Policitemia neonatal
- ☐ D) Anemia fisiológica del lactante
- ☐ E) Requiere transfusión inmediata

PREGUNTA 3

Lactante de 12 meses con hemoglobina de 9,5 g/dL y VCM de 65 fL. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ A) Anemia fisiológica del lactante
- ☐ B) Anemia por déficit de vitamina B12
- ☐ C) Anemia ferropénica
- ☐ D) Talasemia beta
- ☐ E) Anemia hemolítica autoinmune

RESUMEN: ANEMIA EN NIÑOS

Esta clase aborda las particularidades de la anemia en niños. El diagnóstico no se hace con un punto fijo de hemoglobina sino cuando está bajo el percentil 3 (equivalente a 2 desviaciones estándar bajo la media para la edad). Al nacer, el punto de corte es aproximadamente 15 g/dL. Entre los 2 y 6 meses se produce la anemia fisiológica del lactante (recambio de sangre fetal a adulta), con un punto de corte de 9 g/dL. Bajo 9 se debe buscar una causa secundaria. Después de los 6 meses, la hemoglobina se estabiliza en torno a 11 g/dL. Las causas varían según la edad: en el recién nacido predomina la hemólisis por incompatibilidad de grupo o Rh y las anemias genéticas (alfa talasemia); entre 2-6 meses la anemia fisiológica es lo más frecuente; después de los 6 meses la ferropénica es la causa más común por lejos. Se presentan casos clínicos ilustrativos para cada rango etario.